

Fekal Kalprotektin Yüksekliği

Yüksek fekal kalprotektinde organik–fonksiyonel ayrımını yapmaya, enflamatuvar bağırsak hastalığını enfeksiyondan ve yanlış pozitif kaynaklardan ayırt etmeye, eşik değerini yaşa ve klinik bağlama göre yorumlayıp doğru olguyu doğru zamanda endoskopiye yönlendirmeye yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

IBD vs enfeksiyon

Eşik yorumu

Yanlış pozitif

Endoskopi zamanlaması

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Fekal kalprotektin (FK), nötrofil sitozolündeki kalsiyum-bağlayan bir proteindir (S100A8/A9); bağırsak mukozasına nötrofil göçü olduğunda gaitaya salınır ve bu yüzden **mukozal enflamasyonun kantitatif, ancak hastalığa özgü olmayan** bir belirtecidir. Yüksekliği bir tanı değil, "bağırsakta nötrofilik enflamasyon var" sinyalidir; asıl klinik görev bu sinyalin kaynağını (enflamatuvar bağırsak hastalığı mı, enfeksiyon mu, alerjik/diğer organik neden mi, yoksa yanlış pozitif mi) ayırmak ve fonksiyonel bozuklukları (Rome IV) gereksiz endoskopiden korumaktır. FK'nın en güçlü yanı yüksek **negatif prediktif değeridir**: normal/düşük bir FK, kronik karın ağrısı-ishalli bir çocukta IBD olasılığını belirgin düşürür ve endoskopiden kaçınmayı destekler. Eşik yorumu üç ilkeye dayanır: (1) sonuç mutlaka **kit/yönteme özgü referansla** okunur (ELISA ile hızlı testler farklı kalibre olabilir); (2) **yaş** kritik değişkendir — süt çocuğu ve özellikle <1 yaş bebekte FK fizyolojik olarak yüksektir (ilk aylarda birkaç yüz µg/g'a ulaşabilir), bu nedenle erişkin eşiği (<50 µg/g) küçük bebeğe uygulanmaz; (3) tek yüksek değer tanısal değildir — geçici nedenler dışlanıp klinik bağlamla ve gerektiğinde **tekrar ölçümle** teyit edilir. İlk görev; yüksekliğin gerçek mi (örnek/analitik ve fizyolojik yanlış pozitif dışlandı mı), akut-geçici mi yoksa kronik-organik bir tabloya mı işaret ettiğini belirlemek ve kırmızı bayrakları taramaktır.

<50 µg/g: organik olasılık düşük (>4 yaş)

50-250 µg/g: gri bölge → tekrarla

>250 µg/g: organik/IBD güçlü olasılık

Bebek/<1 yaş: fizyolojik olarak yüksek

Kit/yönteme özgü eşik kullan

Öyküde sorgula

- Semptom süresi ve paterni: kronik (>4 hafta) ishal, karın ağrısı, kanlı-mukuslu gaita, **gece semptomları/uyandıran ağrı ve ishal** (organik lehine); tenesmus, dışkılama aciliyeti
- Sistemik-alarm: kilo kaybı, büyüme/boy hızı duraksaması, gecikmiş puberte, ateş, iştahsızlık, yorgunluk
- Ekstraintestinal: artralji-artrit, aftöz stomatit, eritema nodozum-pyoderma, üveit, perianal ağrı-akıntı
- Enfeksiyon bağlamı: akut başlangıç, temas-seyahat, yiyecek öyküsü, yakın antibiyotik (C. difficile), gastroenterit sonrası dönem
- Yanlış pozitif kaynakları: **NSAİİ/aspirin**, **PPI** kullanımı, GİS kanaması (üst/alt), örnek zamanlaması-saklama, menstrüel kontaminasyon, ağır konstipasyon
- Beslenme-alerji: inek sütü protein alerjisi ipuçları (süt çocuğunda kanlı gaita), çölyak riski; ailede IBD/çölyak/otoimmün hastalık öyküsü, konsanguinite

Muayenede değerlendir

- Büyüme antropometrisi ve persentil seyri (boy hızı düşüşü organik hastalığın erken ve hassas göstergesi); Tanner evresi
- Genel durum-beslenme: solukluk (anemi), kas kütlesi kaybı, dehidratasyon, hidrasyon-hemodinami
- Batın: hassasiyet, kitle (sağ alt kadranda inflamatuvar kitle — Crohn), distansiyon, organomegali
- **Perianal muayene** (Crohn için kritik): skin tag, fissür, fistül ağzı, apse, indürasyon; parmakla rektal muayene endikasyonu
- Ekstraintestinal bulgular: oral aft, cilt lezyonları (eritema nodozum), eklem şişliği-hassasiyeti, göz bulguları, çomak parmak
- Enfeksiyöz-akut tablo işaretleri: ateş, akut dizanterik gaita, sistemik toksisite

Kavram: FK yüksekliğinin ilk sorusu "bu sinyal gerçek ve organik mi?" — yaş, ilaç (NSAİİ/PPI), kanama ve örnek hatası gibi yanlış pozitifler dışlanmadan yüksek değer yorumlanmaz. Gerçek ve kalıcı yükseklik, kırmızı bayrak/klinik bağlamla birlikte IBD–enfeksiyon–diğer organik ayırımına; normal FK ise fonksiyonel tanının (Rome IV) desteklenmesine ve endoskopiden kaçınmaya götürür.

FK yüksekliği, bağırsak lümenine nötrofil göçü yapan herhangi bir sürecin ortak sonucudur; ayırıcı tanı bu ortak yolun nedenini bulmaktır. En kritik ayırım **IBD** ↔ **enfeksiyon** ↔ **yanlış pozitif/fizyolojik** üçgenidir: IBD kalıcı-yüksek değer ve kırmızı bayraklarla, enfeksiyon akut-geçici tabloyla, yanlış pozitifler ise yaş/ilaç/örnek ipuçlarıyla ayrılır. Fonksiyonel bozukluklarda (IBS, fonksiyonel karın ağrısı) FK tipik olarak normaldir; yüksek FK fonksiyonel tanıyı sorgulattır.

Enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD)

- Crohn hastalığı, ülseratif kolit, ayrılamayan IBD (IBD-U); FK sıklıkla belirgin ve kalıcı yüksek
- Kırmızı bayrak birlikteliği: kilo/boy hızı kaybı, kanlı ishal, perianal hastalık, ekstraintestinal bulgu, ailede IBD
- FK mukozal enflamasyonu yansıtır: tanı sonrası aktivite ve nüks izleminde de kullanılır

Enfeksiyöz enterokolit

- Bakteriyel: Salmonella, Shigella, Campylobacter, invaziv/enteroinvaziv E. coli, Yersinia (Crohn taklit eder)
- Clostridioides difficile (yakın antibiyotik); paraziter: Giardia, amep; bazı viral gastroenteritler
- Tipik olarak akut-geçici; tedavi/iyileşme sonrası 4-6 haftada FK geriler — organikten ayıran anahtar

Yanlış pozitif / analitik-fizyolojik

- **Yaş:** süt çocuğu ve <1 yaş bebekte fizyolojik yükseklik; erken çocuklukta eşik daha esnek
- **İlaç:** NSAİİ/aspirin (mukozal hasar), PPI; GİS kanaması (kaynağı ne olursa olsun FK'yı yükseltir)
- **Örnek/analitik:** uygunsuz saklama-zamanlama, menstrüel/idrar kontaminasyonu, ağır konstipasyon, kit farkı

Alerjik / eozinofilik

- İnek sütü protein alerjisi (süt çocuğunda kanlı-mukuslu gaita ile), diğer besin protein enteropati/kolitleri
- Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar (eozinofilik kolit/enteropati)
- Eliminasyon-provokasyon yanıtı ve klinik bağlam ayırt eder; FK orta düzeyde yükselebilir

Diğer organik nedenler

- Çölyak hastalığı (değişken FK), otoimmün enteropati, juvenil-jüvenil polip ve polipozis
- NSAİİ enteropatisi, mikroskopik kolit, GVHD, nekrotizan enterokolit (yenidoğan), kistik fibroz
- Vaskülit/İSK vaskülitleri (ör. IgA vaskülit bağırsak tutulumu), radyasyon/ilaç koliti

Fonksiyonel / normal beklenen

- Rome IV fonksiyonel bozukluklar: IBS, fonksiyonel karın ağrısı, fonksiyonel ishal → FK tipik olarak normal
- Normal FK bu tanıları destekler ve endoskopiden kaçınmayı sağlar (yüksek NPV)
- Yüksek FK, "fonksiyonel" etiketini sorgulattır — organik nedeni yeniden ara

Eşik kuralı: >4 yaş çocukta FK <50 µg/g organik hastalık olasılığını düşürür; 50-250 µg/g gri bölgedir (geçici neden ara, 4-6 haftada tekrarlar); >250 µg/g organik/IBD lehine güçlüdür ve kırmızı bayrak varlığında endoskopiye götürür. Değerler kit/yönteme özgü referansla ve yaşla birlikte yorumlanmalı; bebekte fizyolojik yükseklik unutulmamalıdır.

03 Karar akışı

İlk çatal, yüksekliğin gerçek olup olmadığı (yanlış pozitif/fizyolojik dışlama); ikinci çatal, tablonun akut-enfeksiyöz mü yoksa kronik-organik mı olduğu; üçüncü çatal ise kırmızı bayrak + eşik değere göre endoskopi kararıdır. Amaç, IBD'li azınlığı hızla doğru yola sokarken fonksiyonel çoğunluğu gereksiz endoskopiden korumaktır.

BAŞLANGIÇ

Yüksek fekal kalprotektin saptandı

Değeri kit/yönteme özgü referansla ve yaşa göre yorumla. Bebek/<1 yaşta fizyolojik yüksekliği hatırla; sonucu klinik bağlam olmadan tek başına yorumlama.

ADIM 1

Yanlış pozitifleri ve örnek hatasını dışla

NSAİİ/aspirin-PPI kullanımı, GİS kanaması, menstrüel/idrâr kontaminasyonu, uygunsuz örnek saklama-zamanlama ve ağır konstipasyonu sorgula. Şüpheli/sınırdaki değeri uygun koşullarda tekrarla.

KARAR 1

Akut enfeksiyöz tablo veya geçici bir neden var mı?

Akut başlangıç, ateş, dizanteri, yakın antibiyotik (C. difficile), temas-seyahat öyküsü ya da NSAİİ/kanama gibi geçici neden mevcut mu?

EVET → Enfeksiyon/geçici neden

HAYIR → Kronik/organik yol

HEDEFE YÖNELİK

Enfeksiyonu araştır, tedavi et, FK'yı tekrarla

Gaita kültürü/PCR, C. difficile (GDH+toksin), Giardia antijeni; patojene özgü tedavi ya da geçici nedeni gider. İyileşme sonrası **4-6 haftada FK tekrarı** ile normalleşmeyi belgele.

İLERLE

Organik tarama ve kırmızı bayrak değerlendirmesi

Kronik semptomlarda tam kan, CRP/ESH, albümin, ferritin, çölyak serolojisi (tTG-IgA + total IgA); büyüme ve perianal muayene ile klinik ağırlığı belirle.

KARAR 2

Kırmızı bayrak var mı ve FK belirgin/kalıcı yüksek mi (>250 µg/g)?

Kanlı ishal, kilo/boy hızı kaybı, perianal hastalık, ekstraintestinal bulgu, anemi-hipoalbuminemi-trombositoz ya da yüksek CRP eşlik ediyor mu?

EVET → Endoskopi

TANISAL

İleokolonoskopi + üst GİS endoskopisi (Porto)

Segmental biyopsilerle tam ileokolonoskopi ve özofagogastroduodenoskopi; ince bağırsak için MR enterografi. IBD tanısı, sınıflaması ve yaygınlığı için standart yol; süt çocuğunda erken başlangıçlı IBD/monogenik zemini değerlendir.

HAYIR → Gri bölge/izlem

İZLE

Tekrar ölçüm ve klinik takip

Kırmızı bayrak yok, FK gri bölgede (50-250 µg/g): 4-6 haftada FK'yı tekrarla ve klinik izle. Kalıcı yükseklik veya yeni alarm bulgusu endoskopi kararını yeniden gündeme getirir; normalleşme fonksiyonel tanıyı destekler.

Not: FK tek başına IBD tanısı koydurmaz da dışlamaz da; gücü, kırmızı bayrak yokluğunda düşük değerle endoskopiden kaçınmayı, yüksek değer + alarm bulgusuyla ise endoskopiye zamanında tetiklemeyi sağlamaktır. Enfeksiyon ile organik hastalığı ayırmanın en pratik aracı, geçici nedeni giderdikten sonra 4-6 haftada FK'yı tekrarlamaktır.

Tetkik, yüksekliğin doğrulanması ve yanlış pozitiflerin elenmesiyle başlar; enfeksiyon dışlanır, organik tarama yapılır ve kırmızı bayrak + eşik değere göre görüntüleme ve endoskopiye ilerlenir. Kırmızı bayrağı olmayan gri bölge değerlerde ileri tetkiki genişletmeden tekrar ölçüm/izlem esastır.

Yüksek fekal kalprotektinde kademeli değerlendirme

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Doğrula ve yanlış pozitifleri ele	FK tekrarı (uygun örnek/saklama); NSAİİ-PPI-kanama-menstrüasyon-konstipasyon sorgusu	Kit/yönteme özgü eşik ve yaşa göre yorumla; bebekte fizyolojik yükseklik; sınırda değeri tekrarla
Basamak 2 · Enfeksiyonu dışla	Gaita kültürü ve/veya çoklu patojen PCR paneli; C. difficile (GDH + toksin); Giardia antijeni-parazit; gaitada gizli kan	Akut/dizanterik tabloda önce enfeksiyon; tedavi/iyileşme sonrası 4-6 haftada FK tekrarı organik-geçici ayrımını yapar
Basamak 3 · Organik laboratuvar tarama	Tam kan sayımı, CRP, ESH, albümin, ferritin/demir, ALT-GGT; çölyak serolojisi (tTG-IgA + total IgA)	Anemi, trombositoz, hipoalbüminemi, yüksek CRP/ESH organik/IBD lehine; büyüme parametreleri ile birlikte değerlendir

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 4 · Görüntüleme	Abdominal ultrasonografi; ince bağırsak değerlendirmesi için MR enterografi (radyasyonsuz tercih)	Bağırsak duvar kalınlaşması, inflamatuvar kitle/apse, ince bağırsak Crohn tutulumu; perianal şüphede pelvik MR
Basamak 5 · Endoskopi (tanısal)	Tam ileokolonoskopi + özofagogastroduodenoskopi, çoklu segmental biyopsi (ESPGHAN revize Porto)	Kırmızı bayrak + belirgin/kalıcı FK yüksekliğinde; IBD tanısı-sınıflama-yaygınlık; histoloji zorunlu
Basamak 6 · Seçili ileri tetkik	Kapsül endoskopi (ince bağırsak Crohn şüphesi, normal ileokolonoskopi); erken başlangıçlı IBD'de monogenik/immünolojik değerlendirme	<6 yaş (özellikle <2 yaş) başlangıçta monogenik IBD; kapsül öncesi darlık ekartasyonu
İzlem · Tedavi yanıtı	Seri FK ölçümü (tanı sonrası aktivite/mukozal iyileşme ve nüks izlemi)	Bireysel bazal değere göre trend; yükseliş klinikten önce nüksü haber verebilir

Sıralama ilkesi: Akut-dizanterik tabloda önce enfeksiyon dışlanır; kronik semptom + kırmızı bayrak + belirgin FK yüksekliğinde endoskopi geciktirilmez. Kırmızı bayrağı olmayan gri bölge değerlerde en doğru adım, ileri görüntüleme-endoskopiye savurmadan 4-6 haftada FK'yı tekrarlamak ve klinik izlemektir.

Aşağıdakilerden herhangi biri, yüksek FK'nın fonksiyonel/geçici olmadığını; IBD ya da başka bir organik hastalığın bulunduğunu düşündürür ve hızlı organik değerlendirme ile zamanında endoskopiye gerektirir.

- Rektal kanama / kanlı-mukuslu ishal, dışkılama aciliyeti-tenesmus

- Kilo kaybı, büyüme/boy hızı duraksaması, gecikmiş puberte (organik hastalığın hassas göstergesi)

- Perianal hastalık: fistül, apse, geniş skin tag, dirençli fissür, indürasyon (Crohn)

- Gece semptomları: uykudan uyandıran ishal ve karın ağrısı

- Ekstraintestinal bulgular: artrit-artralji, eritema nodozum/pyoderma, üveit, dirençli aftöz stomatit

- Belirgin ve kalıcı FK yüksekliği (>250-500 µg/g), klinik tabloyla uyumlu ve tekrar ölçümde süren

- Laboratuvar: anemi, hipoalbuminemi, trombositoz, yüksek CRP/ESH, demir eksikliği

- Kronik (>4 hafta) ishal veya karın ağrısı; ateş ve sistemik yorgunluk eşliği

- Ailede IBD/otoimmün hastalık öyküsü, konsanguinite; <6 yaş (özellikle <2 yaş) başlangıç (erken başlangıçlı/monogenik IBD)

- Enfeksiyon tedavisine/iyileşmeye rağmen FK'nın 4-6 haftada normalleşmemesi (geçici neden lehine değil)

06 Tedavi

Yüksek FK'nın tedavisi **etiyojiye yöneliktir**; FK'yı düşürmeye değil, altta yatan süreci tedavi etmeye odaklanılır. Yanlış pozitif/fizyolojik nedende ilaç değil, nedeni giderme ve tekrar ölçüm; enfeksiyonda patojene özgü tedavi; inek sütü protein alerjisinde eliminasyon uygulanır. IBD doğrulandığında tedavi indüksiyon (remisyona sokma) ve idame (remisyonu koruma) olarak yürütülür; Crohn hastalığında birinci basamak indüksiyon **eksklüzif enteral nütrisyondur (EEN)**. Aşağıdaki dozlar başlıca tanı gruplarına göre verilmiştir; ağırlık, karaciğer-böbrek fonksiyonu, TPMT/tiopürin metabolizması ve terapötik ilaç izlemine göre bireyselleştirilmelidir.

Etiyojiye göre tedavi ve dozlar	
DURUM / İLAÇ	DOZ
Yanlış pozitif / fizyolojik	İlaç yok — nedeni gider, tekrar ölç
C. difficile enfeksiyonu (ilk atak)	Oral vankomisin 40 mg/kg/gün, 4 doza bölünmüş (maks 500 mg)
Bakteriyel enterokolit	Patojene özgü (endike ise); ör. Shigella/ağır Campylobacter içi

DURUM / İLAÇ	DOZ
İnek sütü protein alerjisi	Aşırı hidrolize formül; yanıtı olmazsa aminoasit bazlı formül; anne sütü
Crohn — indüksiyon (1. basamak)	Eksklüzif enteral nütrisyon (EEN): polimerik formül, enerji ihtiyacı karşılanmalı
Kortikosteroid (indüksiyon)	Prednizolon/prednizon 1-2 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün), yanıt olmazsa
5-ASA / mesalazin (hafif-orta UK)	50-80 mg/kg/gün oral (maks 4.8 g/gün); topikal/rektal formlar da kullanılabilir
Tiyopürin (idame)	Azatiyoprin 2-2.5 mg/kg/gün veya 6-merkaptopürin 1-1.5 mg/kg/gün

DURUM / İLAÇ	DOZ
Anti-TNF (biyolojik)	İnfliksımab 5 mg/kg IV, 0-2-6. hafta indüksiyon, sonra her 8 haf
Perianal fistülize Crohn (adjuvan)	Metronidazol 15-20 mg/kg/gün /3 (maks 1-1.5 g/gün) ± siproflo

Yaklaşım: Önce yüksekliğin yanlış pozitif mi, enfeksiyöz-geçici mi yoksa organik mi olduğunu ayır. Yanlış pozitifte nedeni gider ve tekrarla; enfeksiyonda hedefe yönelik tedavi ver ve FK'yı 4-6 haftada teyit et; IBD'de indüksiyon (Crohn'da öncelikle EEN) ile remisyona sok, uygun idame (tiyopürin/biyolojik) ile koru ve tedavi yanıtını seri FK ile izle.

Dikkat: FK'yı "düşürmek" için gereksiz IBD ilacı başlama — tedavi tanıya dayanmalıdır. Kortikosteroid idamede kullanılmaz ve büyümeyi baskılar; steroide bağımlı seyirde erken idame/biyolojik planla. Anti-TNF öncesi latent tüberküloz ve enfeksiyon taraması, tiyopürin öncesi TPMT/NUDT15 değerlendirmesi ihmal edilmemelidir.

Yönetim; yanlış pozitifleri ayıklamaya, fonksiyonel çoğunluğu gereksiz endoskopiden korumaya ve organik hastalığı (özellikle IBD'yi) zamanında tanıyıp seri FK ile izlemeye dayanır. FK'nın en değerli kullanımı hem tanı öncesi tarama (yüksek NPV) hem de tanı sonrası aktivite/nüks takibidir; yorum daima yaş, kit ve klinik bağlamla birlikte yapılır.

İzlem ve takip

- Gri bölge (50-250 µg/g) ve kırmızı bayraksız değerlerde 4-6 haftada FK tekrarı ile trendi belgele; normalleşme fonksiyonel tanıyı destekler
- Enfeksiyon/geçici nedende iyileşme sonrası FK'nın normalleşmesini teyit et; süren yükseklik organik yolu yeniden açar
- IBD tanısında bireysel bazal FK'ya göre seri ölçüm; mukozal iyileşme hedefi ve subklinik nüksün erken yakalanması
- Büyüme-persentil, Tanner evresi, hemogloblin-albümin-CRP izlemi; büyüme duraksaması tedavi yoğunlaştırma sinyali
- İlaç güvenliği: tiyopürinde tam kan-KCFT, biyolojikte enfeksiyon-terapötik düzey; steroid maruziyetini en aza indir
- Yorum tuzakları: kit değişiminde bazal yeniden belirle; NSAİİ/PPI-örnek koşullarını her ölçümde gözden geçir

Yönetim ve güvenlik ağı

- Etiyolojiye özgü tedaviyi zamanında uygula (enfeksiyonda hedefe yönelik, alerjide eliminasyon, IBD'de indüksiyon-idame)
- Kırmızı bayrak + belirgin/kalıcı FK yüksekliğinde endoskopiye geciktirme; normal FK + fonksiyonel tabloda invaziv tetkikten kaçın
- Aileye yazılı uyarı: kanlı ishal, kilo kaybı, gece semptomları, perianal ağrı-akıntı, ateş-eklemler/göz bulgusu gelişiminde erken dönüş
- Erken başlangıçlı IBD'de (<6, özellikle <2 yaş) monogenik/immünolojik değerlendirme ve ilgili merkezle ortak yönetim
- Test savurganlığından kaçın: yüksek FK'yı yanlış pozitif ve enfeksiyon açısından süzmeden endoskopi/görüntülemeye geçme
- IBD'de beslenme-kemik sağlığı-aşılama (biyolojik öncesi canlı aşı planı) ve psikososyal desteği yapılandır

En iyi sonuç; FK yüksekliğini yaş ve kit bağlamında yorumlamak, yanlış pozitif ile enfeksiyonu erken süzmek, kırmızı bayrak yokluğunda düşük/gri değerlerle gereksiz endoskopiden kaçınmak, alarm bulgusu + belirgin yükseklikte endoskopiye zamanında yapmak ve tanı sonrası seri FK ile mukozal iyileşme ve nüksü izleyen yapılandırılmış takiple elde edilir.

Kaynaklar

1. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. ESPGHAN revised Porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(6):795-806.
2. van Rhee PF, Van de Vijver E, Fidler V. Faecal calprotectin for screening of patients with suspected inflammatory bowel disease: diagnostic meta-analysis. BMJ. 2010;341:c3369.
3. Koninckx CR, Donat E, Benninga MA, et al. The Use of Fecal Calprotectin Testing in Paediatric Disorders: A Position Paper of the ESPGHAN Gastroenterology Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021;72(4):617-640.
4. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Fekal kalprotektin değerleri kit/yönteme özgü referans aralığı ve yaşla birlikte yorumlanmalı; dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, organ fonksiyonlarına ve terapötik ilaç izlemine göre teyit edilmelidir.